

男性尿道吊带

WARWIKI

患者须知 · 用于治疗前列腺手术后漏尿的吊带

男性吊带是一条柔软的补片，放置于尿道（排尿的通道）下方，用于治疗漏尿——尤其是前列腺手术后咳嗽、提重物或活动时发生的漏尿。它通过托起并支撑尿道，帮助您更好地控制排尿。与人工括约肌不同，吊带无需任何操作。本手册介绍其原理、术前准备及术后注意事项。

关于这项手术

活动、咳嗽或提重物时漏尿称为**压力性尿失禁**，常见于前列腺手术后。吊带通过在尿道下方放置一条柔软的补片并将尿道轻轻托回正常位置来治疗漏尿。

吊带的作用是**支撑**尿道，而非将其夹紧，因此愈合后您可以**正常排尿**——无需操作任何泵、按钮或装置。

重要须知

吊带最适合仍有一定括约肌功能的**轻至中度**漏尿患者，您的医生会事先评估。对于较严重的漏尿，或曾接受过**盆腔放疗**的患者，**人工尿道括约肌（AUS）**通常是更好的选择——您的医生会与您讨论哪种方案更适合。吊带可能大幅**减少**漏尿而非完全消除，若效果不足，之后仍可放置括约肌。

名词解释

压力性尿失禁

活动、咳嗽或提重物时漏尿。

尿道

将尿液从体内排出的通道。

吊带

放置于尿道下方以托起并支撑尿道的柔软补片条。

复位检查

用小型摄像头观察内部，确认托起尿道可能有效。

尿潴留

术后暂时性排尿困难；可能需短期使用导尿管。

人工括约肌（AUS）

替代装置，带有泵，通常用于较严重的漏尿。

全身麻醉

手术期间使您保持睡眠状态、无痛感的药物。

会疼吗？ 手术在全身麻醉或椎管内麻醉下进行，术中不会有任何感觉。术后腹股沟及阴囊与肛门之间的区域会出现酸痛、肿胀和淤青，持续约两周——冰敷、阴囊托和止痛药可缓解。手术约需一小时，许多患者当天即可回家。

如何准备（术前）

- 手术在**全身麻醉或椎管内麻醉**下进行——请遵守所有手术指示（禁食及需暂停的药物，包括抗凝药）。
- **尿液检查**排除感染（如有感染需先治疗），**膀胱镜检查**确认吊带可能有效。
- **戒烟**，控制体重和血糖，按医嘱使用抗生素——吊带是植入体内的补片。

请提前告知医疗团队您是否：

- 曾接受**盆腔放疗**——吊带效果往往较差，括约肌可能是更好的选择
- 曾接受过其他控尿手术或有尿道狭窄
- 身体任何部位存在感染

手术过程

- 1 您将在麻醉下进入睡眠状态或腰部以下失去感觉，同时给予抗生素。
- 2 医生通过腹股沟及阴囊与肛门之间的小切口，将网状吊带置于尿道下方并托至合适位置。
- 3 固定吊带，缝合切口，通常短期放置导尿管。

之后

- 腹股沟及会阴区会有**酸痛、肿胀和淤青**，持续1-2周。使用冰敷、阴囊托和止痛药。
- 数周内（通常约6周）**避免重体力劳动、用力、骑车及性生活**——用力可能导致吊带在愈合前移位。
- 可能出现**暂时性排尿困难**，需短期使用导尿管；通常会自行好转。
- 初期继续使用尿垫——改善效果可能在随后数周内逐渐显现。吊带**无需任何操作**，愈合后排尿恢复正常。

出现以下情况请联系您的医疗团队：

- **完全无法排尿**
- 发热或寒战，或切口处出现红肿加重、疼痛或分泌物
- 腹股沟或会阴疼痛加重

需要记住的三件事

1. 男性尿道吊带是放置于尿道下方的补片条，通过托起并支撑尿道改善前列腺手术后的尿控——无需任何操作。
2. 最适合**轻至中度**漏尿；对于较严重的漏尿或放疗后，人工括约肌通常效果更好——必要时之后仍可放置。
3. 术后数周内**避免重体力劳动、用力、骑车及性生活**，以利吊带愈合。如完全无法排尿或出现感染迹象，请立即就医。